

Mobilización social y autogestión en salud

Breve descripción:

Este componente formativo trata sobre la movilización social y la autogestión, impulsadas por la organización comunitaria y el empoderamiento. Promueve la participación activa, la toma de decisiones autónomas y el uso eficiente de recursos para transformar la salud pública. Se utilizan herramientas como el árbol de soluciones, la espina de pescado y SARAR para fortalecer el análisis y la acción colectiva.

Noviembre de 2025

Contenido

Introducción	1
1. Movilización social	4
1.1 Autogestión	7
1.2 Participación social: definición, normativa y formas	15
1.3 Organización y empoderamiento	25
1.4 Herramientas de análisis.....	27
Síntesis	41
Material complementario.....	43
Glosario	45
Referencias bibliográficas	46
Créditos.....	50

Introducción

En este componente formativo se revisarán los conceptos relacionados con la movilización social y la autogestión comunitaria como procesos fundamentales para transformar la salud pública en Colombia, permitiendo que la población identifique problemas, participe activamente y gestione recursos para promover su bienestar. Estos modelos parten del fortalecimiento organizativo, el empoderamiento y la corresponsabilidad en la toma de decisiones, superando enfoques individualistas y verticales.

El éxito radica en articular la organización comunitaria, el liderazgo social, la inclusión y la solidaridad, mediante la construcción de redes colaborativas, el uso de metodologías participativas y herramientas analíticas que aseguren diagnósticos acertados, planeación colectiva y evaluación permanente de los resultados. Así, la comunidad se convierte en motor y agente activo del cambio social y sanitario.

Finalmente, la implementación de estrategias como el árbol de soluciones, la espina de pescado y la metodología SARAR, permiten analizar y abordar integralmente las necesidades, causas y posibles soluciones de los problemas de salud, fortaleciendo la capacidad para la acción colectiva, la gestión eficaz y la sostenibilidad de los logros alcanzados en el territorio.

Por lo anterior, se invita a conocer el siguiente video que contextualiza sobre la temática a tratar:

Video 1. Movilización social y autogestión en salud



Enlace de reproducción del video

Video 1. Síntesis del video: Movilización social y autogestión en salud

¡Bienvenidos! Este componente formativo marca el inicio de la fase de acción dentro de la Estrategia de Vigilancia Basada en la Comunidad (VBC).

Después de analizar la comunidad, identificar riesgos y realizar reportes oportunos, ahora se busca implementar acciones de mejora que respondan a las situaciones de salud detectadas, demostrando el impacto transformador de esta estrategia.

El objetivo principal es empoderar a la comunidad para que, liderada por sus Vigías y Gestores, diseñe e implemente soluciones sostenibles a los problemas de salud identificados en su territorio.

Este proceso se fundamenta en tres pilares clave:

1. Fuerza de la comunidad: movilización y participación

- **Movilización social:** impulsa la acción colectiva, convocando a líderes y organizaciones para ejecutar planes de mejora.
- **Participación social:** garantiza la intervención activa de la comunidad en la toma de decisiones, respaldada por lineamientos que permiten exigir acciones a las instituciones.

2. Capacidad interna: organización, empoderamiento y autogestión

- **Organización y empoderamiento:** fortalece la estructura comunitaria y promueve la autonomía para gestionar sus necesidades en salud.
- **Autogestión:** fomenta soluciones locales con recursos propios, adaptadas a la cultura y cosmovisión de la comunidad.

3. Herramientas para la acción: de la causa a la solución

Se utilizan metodologías como el Árbol de soluciones, el Diagrama de Ishikawa y la Metodología SARAR para transformar causas en acciones concretas, diseñadas participativamente por la comunidad.

¡Ahora es el momento de construir en conjunto las soluciones para el territorio!

1. Movilización social

La movilización social, de acuerdo con Pierre Bourdieu no es un proceso espontáneo sino es un trabajo progresivo por parte del grupo movilizado que tiene por objeto romper el determinismo estructural y la idea que los sujetos sociales se ven arrastrados inevitablemente por presiones externas. Por lo tanto, el movimiento social responde a procesos históricos que adoptan recursos materiales y simbólicos en sus estrategias; en las que lo político y el simbolismo busca reconocimiento y transformación de las condiciones sociales desde la crítica estructural y discursos de dominación (Paris Pombo, 2012).

De igual forma, Laraña refiere que la acción colectiva es la solidaridad para promover o impedir cambios sociales, donde una conducta antes que fuese norma se vuelve controvertida, lo que acarrea un rompimiento de los límites de las normas del sistema y de las relaciones sociales lo que promueve la producción de nuevas normas y legitimaciones en la sociedad (García Jerez, 2016; Tilly & Wood, 2010).

Tilly & Wood consideran que los movimientos sociales son una acción en la que se involucran campañas colectivas que tienen el fin de reportar demandas a las autoridades, manifestaciones y creaciones de redes. A su vez, Melucci refiere que la movilización son redes de actores que a partir de una identidad colectiva para defender o modificar ciertos aspectos sociales mediante estrategias de acción colectiva (Centro de estudios en democracia y asuntos electorales, 2014; Contreras Hernández, 2022; Tilly & Wood, 2010).

Según los anteriores autores, la movilización social presenta ciertas características:

- **Identidad**

Es el motor para una participación colectiva de los miembros filiales.

- **Solidaridad**

La apelación a la solidaridad y la cooperación es fundamental para generar cambios.

- **Acción colectiva organizada**

Incluye desde simples protestas hasta la coordinación estratégica de recursos y discursos.

- **Ruptura y producción de normas**

Los movimientos pueden romper límites normativos y generar nuevas legitimaciones sociales.

- **Duración y estructura informal**

La movilización puede ser transitoria o sostenida, pero siempre más organizada que una simple protesta espontánea.

La consolidación de la movilización social se genera cuando el proceso cuenta con la participación, corresponsabilidad y construcción colectiva de la comunidad. Para cumplir con esto depende de varios elementos, entre ellos están:

- Diagnóstico participativo de necesidades.
- Convocatoria amplia y equitativa de actores sociales.
- Comunicación estratégica culturalmente adecuada.
- Fortalecimiento de capacidades y liderazgo comunitario.
- Evaluación y retroalimentación permanente para asegurar sostenibilidad.

La movilización social es una estrategia clave en salud pública que involucra a la comunidad en la identificación, análisis y resolución de los problemas sanitarios que la afectan directamente. A través de procesos participativos, esta herramienta fomenta el empoderamiento de las personas, permitiéndoles convertirse en agentes de cambio dentro de sus comunidades. Esta metodología ha demostrado ser eficaz en la prevención de enfermedades, el control de brotes y la promoción de hábitos saludables (Eugenio et al., 2014).

Uno de los principales objetivos de la movilización social es generar cambios sostenibles en el comportamiento de la población. Para ello, se fomenta la participación de líderes comunitarios, organizaciones locales y de la comunidad en general en actividades de prevención y control.

En contextos de brotes de enfermedades transmisibles, como dengue, malaria o incluso COVID-19, la movilización social resulta fundamental para:

- Promover la adopción de medidas preventivas.
- Difundir información clave.
- Movilizar recursos locales.

Un ejemplo exitoso de movilización social en salud pública es la eliminación de la malaria en comunidades rurales. A través de campañas educativas, la limpieza de criaderos de mosquitos y la distribución de mosquiteros, las comunidades han logrado reducir significativamente la incidencia de esta enfermedad. Este tipo de intervenciones se logran mediante la colaboración entre actores comunitarios, instituciones de salud y organizaciones no gubernamentales, lo que evidencia la importancia del trabajo conjunto y coordinado.

En Colombia existen diversas movilizaciones en salud. De acuerdo con Torres et al., (2022):

“Las movilizaciones sociales en salud en Colombia son un proceso de acción colectiva de la sociedad civil que busca influir en el cambio social para garantizar la salud como un derecho fundamental. Se enmarca en un estudio internacional del Movimiento de Salud de los Pueblos (MSP) y reúne diversos casos de estudio que demuestran cómo la participación ciudadana se ha convertido en una herramienta clave para exigir la salud en el país. El objetivo común de estos casos es mostrar la capacidad de la sociedad para actuar de manera organizada y concertada con el fin de demandar un sistema de salud más justo y accesible para todos.” Torres et al., (2022).

Estas movilizaciones son un amplio espectro de iniciativas ciudadanas que responden a las deficiencias o desafíos del sistema de salud. El texto no se limita a un tipo de protesta, sino que presenta diversas formas en que la sociedad se involucra: desde el activismo de base hasta la organización formal de comunidades.

1.1 Autogestión

La autogestión, desde una perspectiva técnica, ha sido definida por diferentes autores sociales como un proceso de organización y toma de decisiones autónomas protagonizado por individuos o comunidades, sin mediación de grupos externos. Estas definiciones enfatizan la autonomía, la democracia, la participación y el poder directo sobre los procesos sociales, económicos o políticos involucrados.

Basado en lo anterior, a continuación, se detallan las apreciaciones de diferentes autores:

1. Cornelius Castoriadis

Considera que la autogestión implica autonomía frente a la heteronomía; es decir, la capacidad de regularse y tomar decisiones propias en contraposición a la regulación por parte de otros (instituciones externas o poder establecido). Define la autogestión como el ejercicio directo de la toma de decisiones en todos los asuntos, logrando una transformación radical que trasciende lo económico, lo social y lo político, con abolición de intermediarios especializados (Hudson, 2010).

2. Bourdet y Guillerm

Resaltan que la autogestión es una transformación radical que destruye la noción común de política (como gestión reservada a una casta de políticos) y crea una nueva: la gestión directa de los asuntos por quienes están involucrados, sin intermediarios, en cualquier ámbito social (Hudson, 2010).

3. Denis Rougemont

Indica que es la gestión por parte de comunidades básicas (municipalidades, empresas, regiones) de tareas originalmente estatales, poniendo en manos de estos colectivos la toma de decisiones y el control político del ejercicio de poder (Hudson, 2010).

4. Ruggeri

Propone la autogestión como gestión no jerárquica de la producción y la organización del trabajo, donde las normas y procesos son desarrollados e implementados colectivamente por los propios trabajadores; implica apropiación y transformación dinámica de la organización, modificando reglas y excedentes según necesidades y consensos interno (Bauni, 2022).

5. Peixoto de Alburquerque

Son prácticas sociales basadas en la democracia en la toma de decisiones, que favorecen la autonomía de los colectivos. La gestión y el poder de decisión recaen directamente sobre el grupo, sin delegación a jerarquías externas (Bauni, 2022).

6. Guzmán Miranda y otros

Plantean que la autogestión consiste en cambiar la esencia de la organización social (pasar de la conciencia dominada a una conciencia redentora y participativa), donde los directamente afectados toman decisiones y el poder se democratiza entre todos los miembros (Rodríguez Tamayo, 2019).

7. Montero

Describe la autogestión comunitaria como práctica social donde la comunidad define sus problemas, recursos y soluciones e implementa acciones conjuntas desde la equidad, el empoderamiento y la participación directa en su transformación y autodefinición como sujetos activos (Vera Martínez & Ceballos Villada, 2021).

Las definiciones expresadas por los diferentes autores coinciden en presentar la autogestión como proceso de gestión participativa, democrática y autónoma, que elimina la delegación y jerarquización, y apuesta por la transformación social que desde la base y por los actores directamente involucrados. Se diferencia de otras formas organizativas por su énfasis en la asunción directa del poder y la toma de decisiones, la transformación consciente de las formas de vida y la gestión integral de los asuntos comunitarios o colectivos (Rodríguez Tamayo, 2019).

La consolidación de la autogestión mediante el empoderamiento y autonomía de los colectivos, es la creación de mecanismos de decisión directa, en la que se promueve el uso eficiente y transparente de recursos comunitarios, lo que facilita la generación de soluciones y prácticas autodefinidas, orientadas al bienestar común (Rodríguez Tamayo, 2019).

Por su parte, la autogestión comunitaria en salud pública se refiere al proceso mediante el cual las comunidades desarrollan la capacidad de gestionar sus problemas de salud. Esto implica tomar decisiones autónomas y organizar acciones colectivas que refuercen su capacidad de respuesta ante situaciones de interés en salud pública, lo que permite fortalecer los lazos sociales y la resiliencia de las comunidades frente a emergencias sanitarias.

Estrategias y autogestión en salud en las comunidades

La organización comunitaria es un proceso fundamental que permite a las personas unirse para identificar problemas o metas comunes. Su propósito es movilizar recursos, desarrollar estrategias y lograr objetivos colectivos. Este enfoque es la base de muchas de las iniciativas que buscan el cambio social, ya que promueve la colaboración y el empoderamiento.

Para que la organización comunitaria sea efectiva, debe incluir varios elementos clave. El primer paso es obtener un profundo conocimiento de la comunidad, identificando lo que realmente importa a sus miembros. A partir de ahí, el proceso se centra en generar y utilizar el poder de diversas formas, como el poder político o legislativo para influir en las leyes, el poder del consumidor a través de boicots o el poder jurídico para hacer cumplir las normas. También puede manifestarse como un

poder disociador, por ejemplo, mediante una huelga para reclamar mejores condiciones laborales.(Centro para la Salud y Desarrollo Comunitario de la Universidad de Kansas, 2025).

Una organización comunitaria exitosa también se enfoca en planificar acciones con un propósito claro, lograr la participación activa de la mayoría de los miembros — partiendo de la premisa de que “juntos se puede lograr todo” — y en generar y utilizar otros recursos, como donaciones o apoyo. La comunicación efectiva con la comunidad es vital para mantener a todos informados sobre los objetivos, acciones y la importancia de su participación.

Es crucial entender que la organización comunitaria es un proceso de base. No se trata de que un experto externo imponga una agenda, sino de que los propios miembros de la comunidad participen y utilicen su energía para generar el cambio. El objetivo principal es descubrir lo que es importante para la gente y ayudarles a alcanzar esos objetivos, empoderándolos para mejorar sus vidas. Cuando se realiza de manera efectiva, la organización comunitaria provoca una redistribución del poder, creando una base sólida entre un grupo amplio de personas, especialmente en aquellos a quienes tradicionalmente se les ha negado una voz.(Centro para la Salud y Desarrollo Comunitario de la Universidad de Kansas, 2025).

Existen diversas estrategias de organización y autogestión en las comunidades. Aunque no son excluyentes y pueden combinarse, su comprensión por separado ayuda a los organizadores a definir sus estrategias; por ello, se da una explicación de cada una:

- **Organización para el desarrollo local**

También conocida como desarrollo comunitario, este enfoque se centra en el proceso de fortalecimiento de la comunidad. Su objetivo principal es mejorar la capacidad de la gente para resolver sus propios problemas a través de habilidades como la facilitación de grupos y el pensamiento crítico. El desarrollo local busca fomentar relaciones armoniosas entre personas de diferentes orígenes y se rige por el principio de “ayudar a la gente a ayudarse a sí misma”. Organizaciones como el Cuerpo de Paz son ejemplos claros de este modelo.

- **Planificación social o cambio de políticas**

A diferencia del desarrollo local, que se enfoca en el proceso, la planificación social se centra en obtener resultados concretos para resolver problemas específicos, como la falta de vivienda o la alta criminalidad. Este modelo se basa en datos y estadísticas, lo que lo hace más “científico” y a menudo involucra a expertos o planificadores profesionales. Sus objetivos incluyen la provisión de bienes y servicios, así como evitar la duplicación de esfuerzos y suele ser impulsado por programas estatales o federales.

- **Organización para la acción social o apoyo de sistemas**

Este es quizás el modelo más conocido y visual de organización comunitaria. La acción social es un enfoque de confrontación, guiado por el ideal de la justicia social. Su objetivo es que los miembros de grupos marginados o con poco poder se unan para demandar mayores recursos o un trato equitativo de la comunidad en general. Ejemplos históricos de este modelo incluyen

las manifestaciones por los derechos civiles o las protestas para visibilizar las demandas de ciertos grupos.

- **Coaliciones**

Las coaliciones son una estrategia efectiva y popular. Consisten en la creación de grupos amplios que reúnen a personas y organizaciones diversas — que normalmente no trabajarían juntas — para lograr un objetivo común. El poder de una coalición reside en el poder de la mayoría, ya que al unir a distintos actores se genera la fuerza necesaria para impulsar cambios significativos. Por ejemplo, una coalición para la prevención de enfermedades puede incluir a líderes religiosos, jóvenes, empresarios y funcionarios de salud, creando un frente unido para una causa.

Es importante recordar que estos enfoques no son totalmente independientes; un grupo puede usar tácticas de acción social para un proyecto de desarrollo local o una coalición puede emplear la planificación social para alcanzar sus metas. Sin embargo, categorizarlos de esta manera ayuda a los organizadores a pensar de forma estratégica y a alinear sus métodos con sus valores y objetivos.

Constantemente pueden surgir formas nuevas y diferentes. Obedece a las lógicas comunitarias nacionales y subnacionales (departamental, distrital, comunal, barrial, veredas, etc.) Por lo cual, la autogestión surge como una noción importante para la dinamización de la acción colectiva.

Cómo previamente se mencionó, la autogestión en salud pública es un concepto que se refiere a la capacidad de una persona, familia o comunidad de asumir un rol activo y responsable en el cuidado de su propia salud. Va más allá del autocuidado

individual y se enfoca en el empoderamiento colectivo para la toma de decisiones y la gestión de recursos que impactan el bienestar común.

Este concepto abarca:

1. Autonomía y decisión

Implica que las comunidades no son solo “objetos de cuidados” sino sujetos activos, capaces de tomar decisiones informadas sobre su salud. Esto incluye la gestión de los recursos disponibles, la participación en programas de prevención y la elección de estrategias que se adapten a sus necesidades específicas.

2. Gestión de recursos

En un nivel organizacional, la autogestión también puede significar que los equipos de profesionales o las entidades de atención primaria asumen la responsabilidad y autonomía para gestionar los recursos a su disposición, con el objetivo de optimizar la atención.

3. Proceso integral

La autogestión es un proceso complejo que combina factores sociológicos, culturales, políticos y tecnológicos. No se limita a la esfera médica, sino que busca desarrollar espacios de solidaridad y respeto, donde la comunidad es protagonista de su propio bienestar.

En Colombia esto se conceptualiza y materializa en políticas públicas y herramientas de participación ciudadana y participación social en salud.

1.2 Participación social: definición, normativa y formas

El concepto de participación social posee un amplio espectro de aplicación en las ciencias sociales y de la salud. Si bien su definición no es unívoca (OMS, 2022), se puede conceptualizar como la suma de iniciativas en las que los individuos toman parte activa y consciente en un espacio social. Estas acciones dependen, en la práctica, de la capacidad de los participantes para gestionar estructuras de poder. En consecuencia, la participación se considera hoy como un mecanismo para la reconfiguración de espacios sociales, la inclusión de actores sociales en organizaciones de diversa índole (gubernamentales, no gubernamentales, movimientos) o como una forma de presencia pública orientada a la demanda de situaciones o la exigencia de transformaciones (Instituto de Estudios Latinoamericanos, 2025).

Normatividad

En Colombia, la participación ciudadana y la garantía de la salud están estrechamente vinculadas, formando un todo indivisible. Esta relación se fundamenta al considerarla como un derecho humano y social, un concepto que se consolidó en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, el cual fue ratificado por Colombia en 1978. De acuerdo con lo establecido en la Resolución 2063 de 2017 la salud no es solo un servicio, sino una construcción social que refleja la importancia que una sociedad otorga al bienestar de sus ciudadanos. Este valor se ha plasmado en una serie de normas de obligatorio cumplimiento, lo que le otorga un carácter legal.

En este marco, la participación es fundamental para la plena realización del derecho a la salud. Los ciudadanos tienen la facultad de expresar sus opiniones y de decidir sobre sus políticas, un aspecto que la Ley Estatutaria de Participación 1757 de

2015 promueve y protege. Esta ley, al regular la planeación, el control social y la financiación de los asuntos públicos, establece un marco crucial para que la comunidad participe activamente en la gestión de la salud, entendida como un derecho y un bien público.

Además, la Resolución 0429 de 2016 refuerza esta idea al adoptar la Política de Atención Integral en Salud (PAIS). Este documento subraya la necesidad de una retroalimentación constante en el modelo de atención para mejorar los resultados en salud. Para ello, se deben implementar planes que incluyan estrategias de educación, comunicación y gestión que permitan la participación social en salud como un proceso continuo y dinámico. En esencia, la realización de este derecho no es posible sin una participación activa y efectiva de la ciudadanía.

Basado en lo anterior y a lo expuesto por el Ministerio de Salud y Protección Social en su normatividad 2015 - 2017, se relacionan los siguientes contenidos, los cuales tratan el marco legal del derecho a la salud y a la participación:

1. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC)

Como tratado internacional, establece el derecho fundamental de toda persona a disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental (Artículo 12). Aunque no detalla mecanismos de participación, su ratificación por Colombia obliga al Estado a garantizar este derecho. Esto crea el marco general para que la ciudadanía participe en la formulación de políticas que afectan su salud, un principio que se desarrolla en la legislación nacional (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 1976).

2. Constitución Política de Colombia

La Constitución sienta las bases del Estado Social de Derecho y de la participación ciudadana de la siguiente manera:

- Artículo 49: establece que la salud es un servicio público a cargo del Estado y que los ciudadanos deben participar en su control.
- Artículo 103: fomenta la participación de la ciudadanía en la gestión pública.
- Artículo 365: declara que los servicios públicos (incluida la salud) son inherentes a la finalidad social del Estado y que su prestación debe ser eficiente, bajo un marco de participación de la comunidad (Constitución Política de la República de Colombia, 1991).

3. Ley 1438 de 2011

Esta ley fortalece la participación social en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, destacando lo siguiente:

- Artículo 101: regula la participación de todos los actores del sistema de salud y de la ciudadanía. Busca empoderar a la comunidad para que participe en la toma de decisiones, la planeación y la evaluación de la gestión en salud, promoviendo la rendición de cuentas (Ministerio de Salud y Protección Social, 2011).

4. Ley Estatutaria en Salud 1751 de 2015

Eleva la salud a la categoría de derecho fundamental, así:

- Artículo 12: este es el pilar de la participación social en salud. Consagra el derecho de las personas a participar en la formulación, gestión, evaluación y auditoría de las políticas de salud. Obliga a las entidades del sector a

garantizar este derecho a través de mecanismos efectivos y oportunos (Congreso de Colombia, 2015).

5. Resolución 429 de 2016

Adopta la Política de Atención Integral en Salud (PAIS). En su Eje 4: Participación social y ciudadana, establece las directrices para la participación de la comunidad en la definición de las políticas y en la gestión de la salud a nivel territorial. Su objetivo es empoderar a la población y a las organizaciones sociales para que sean agentes de cambio y veedores del sistema (Ministerio de Salud y Protección Social, 2016).

6. Ley Estatutaria 1757 de 2015

A pesar de no ser una ley específica de salud, su impacto es directo. Regula y promueve mecanismos de participación ciudadana en la gestión pública, como las audiencias públicas, las consultas y la iniciativa populares normativa. Estos mecanismos son plenamente aplicables al sector de la salud, complementando las disposiciones de la Ley 1751 y fortaleciendo el derecho de la ciudadanía a influir en las decisiones de política pública (Congreso de Colombia, 2015).

7. Materialización del derecho humano a la salud y participación social en salud

Esta declaración resume el espíritu de todo el marco normativo. Cada una de las leyes y resoluciones mencionadas consolida el principio de que la salud es un derecho fundamental que trasciende la simple atención médica. Implica que la ciudadanía debe tener una participación activa y con capacidad de decisión en cada etapa del ciclo de la política de salud, desde su diseño hasta su evaluación,

asegurando que el sistema responda verdaderamente a las necesidades de la población (Congreso de Colombia, 2015).

De igual forma, la Ley Estatutaria 1757 de 2015, establece que la ciudadanía tiene un papel fundamental en el sistema de salud, con derechos claros para ejercer la participación de manera activa y con capacidad de decisión. La ley establece una serie de formas concretas en las que los ciudadanos pueden involucrarse en la política de salud, asegurando que sus voces sean escuchadas en todo el ciclo.

Este derecho incluye la posibilidad de participar en la formulación de la política en salud y en el diseño de los planes para su implementación. Adicionalmente, permite a los ciudadanos ser parte de los programas de promoción y prevención, así como unirse a instancias de deliberación, veeduría y seguimiento del sistema para garantizar su correcto funcionamiento.

Finalmente, la ley otorga a la ciudadanía el poder de influir directamente en las decisiones críticas del sector. Esto abarca la participación en la inclusión o exclusión de servicios y tecnologías, la definición de las prioridades de salud y las decisiones que puedan implicar una restricción en el acceso a los establecimientos de salud. La participación también se extiende a la evaluación de los resultados de las políticas de salud, cerrando el ciclo de intervención ciudadana.

La Política de Participación Social en Salud (PPSS) (Resolución 2063 de 2017), es una respuesta del Ministerio de Salud y Protección Social para cumplir con la Ley Estatutaria de Salud 1751 de 2015, que consagra la salud como un derecho fundamental y establece la participación como un elemento clave. La PPSS plantea los siguientes ejes estratégicos:

- **Eje 1. Fortalecimiento institucional**

Este eje busca que las entidades del Estado, tanto a nivel nacional como territorial, fortalezcan sus capacidades para garantizar la participación social en salud. Esto implica una serie de acciones concretas, como la asignación de recursos financieros, humanos y logísticos para el fomento de la participación. También se enfoca en la capacitación del personal del sector salud en herramientas pedagógicas para la intervención comunitaria y en la transversalización de los procesos de participación en el ciclo completo de las políticas públicas de salud. Además, contempla la realización de los ajustes normativos necesarios para que la participación sea efectiva.

- **Eje 2. Empoderamiento de la ciudadanía y las organizaciones sociales en salud**

Este eje se centra en desarrollar las capacidades de los ciudadanos y sus organizaciones para que puedan ejercer su rol activo y el pleno de sus derechos en salud. Las líneas de acción incluyen la creación de una estrategia pedagógica permanente para cualificar a la ciudadanía y el establecimiento de incentivos para fomentar su participación. También se promueve el uso de tecnologías de información y comunicación (TIC) y la gestión de recursos para financiar iniciativas comunitarias. El objetivo es fortalecer la legitimidad de la representación ciudadana y ampliar la base de participantes para generar sinergias en pro del derecho a la salud.

- **Eje 3. Impulso a la cultura de la salud**

Este eje promueve la salud como una construcción social y un bien público, incentivando el autocuidado individual y colectivo. Las acciones están orientadas a diseñar una estrategia de comunicación para difundir una

cultura de bienestar con perspectiva comunitaria. Se busca, además, la formación de formadores comunitarios en salud pública para que la propia comunidad sea un actor clave en la promoción de la salud y la prevención de enfermedades. El eje busca que la ciudadanía se apropie de los programas de promoción y prevención.

- **Eje 4. Control social en salud**

Este eje se enfoca en fortalecer la capacidad de la ciudadanía y las veedurías para ejercer el control sobre las instituciones, los recursos públicos y los actores del sistema de salud. Para ello, se establece la necesidad de impulsar procesos de capacitación y formación para que los ciudadanos adquieran las herramientas necesarias para ejercer una vigilancia efectiva. El fin último es garantizar la transparencia, la adecuada inversión de los recursos y el cumplimiento de los planes de beneficios, lo que es crucial para la garantía del derecho a la salud (Política de participación social en salud - Resolución 2063 de 2017).

Basado en lo que representa cada uno de estos ejes estratégicos y la resolución en mención, a continuación, se relacionan las líneas de acción de la PPSS:

1. Fortalecimiento institucional

- Destinar y gestionar recursos financieros y humanos.
- Definir programas de formación y capacitación para el personal de salud.
- Asistencia técnica a entidades territoriales para la implementación de la política.
- Mecanismos de cofinanciación para proyectos de participación.

- Gestiones interinstitucionales para la formación comunitaria en planeación y control social.
- Transversalizar los procesos de participación en el ciclo de las políticas públicas.
- Realizar ajustes normativos para facilitar la participación.

2. Empoderamiento de la ciudadanía y las organizaciones sociales en salud

- Crear una estrategia pedagógica permanente para cualificar a los ciudadanos.
- Establecer incentivos que promuevan la participación.
- Impulsar y promocionar el uso de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC).
- Fortalecer las estrategias de información y comunicación.
- Promover formas de convocatoria que reconozcan las dinámicas territoriales.
- Gestionar recursos para financiar iniciativas comunitarias.
- Definir lineamientos para que las entidades territoriales garanticen la participación.
- Fortalecer la representación de las comunidades en espacios de incidencia política.
- Definir mecanismos de consulta y transferencia de información.

3. Impulso a la cultura de la salud

- Diseñar una estrategia de comunicación para promover una cultura de bienestar.

- Impulsar un programa de formación para formadores comunitarios en salud pública.
- Conformar y consolidar mecanismos para que la ciudadanía se apropie de los programas de promoción y prevención.
- Incorporar la política de participación en los lineamientos de salud pública.

4. Control social en salud

Impulsar procesos de capacitación y formación para el desarrollo de capacidades ciudadanas en el control social.

Es de resaltar que los ejes 2, 3 y 4 de la Política de Participación Social en Salud (PPSS), responden al empoderamiento de las comunidades al otorgarles las herramientas, el conocimiento y la capacidad para ser actores activos y no solo receptores pasivos del sistema de salud. Cada uno de estos ejes contribuye de manera diferente y complementaria para lograr este objetivo.

Por lo anterior, cada uno de estos tres ejes representa lo siguiente, basado en la normativa de análisis que es la Resolución 2063 de 2017:

- **Eje 2**

Se centra directamente en el empoderamiento de las comunidades al fortalecer sus capacidades para participar activamente en el sistema de salud. A través de la implementación de estrategias pedagógicas permanentes y la promoción de incentivos, la política busca que la ciudadanía y sus organizaciones adquieran el conocimiento y las habilidades necesarias para influir en las decisiones. Asimismo, al impulsar el uso de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) y fortalecer la

representación comunitaria, este eje dota a las personas de los canales y espacios formales para que sus voces sean escuchadas y sus propuestas, tenidas en cuenta en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas de salud.

- **Eje 3**

Potencia el empoderamiento al cambiar la percepción de la salud de un servicio a un bien público y una construcción social. Al promover una cultura de la salud, las comunidades se apropian de su bienestar a través del autocuidado y el cuidado colectivo. Esto las empodera al convertirlas en protagonistas de su propia salud, incentivándolas a participar en programas de promoción y prevención, así como a trabajar en conjunto para mejorar las condiciones de vida de su entorno. En lugar de depender de las instituciones para resolver sus problemas, la comunidad se convierte en un agente de cambio proactivo, lo que es una forma de empoderamiento fundamental.

- **Eje 4**

Otorga a las comunidades la capacidad de vigilancia y rendición de cuentas. Al fortalecer el control social, la política reconoce el derecho de los ciudadanos a supervisar la gestión de los recursos públicos, la calidad de los servicios y el cumplimiento de los planes de salud. Esto dota a la comunidad de una herramienta de poder político y ciudadano para exigir transparencia y asegurar que el sistema de salud responda a sus necesidades reales, garantizando que el derecho a la salud se cumpla de manera efectiva.

1.3 Organización y empoderamiento

La organización comunitaria es un proceso dinámico mediante el cual personas que comparten un territorio, una problemática o un interés común, se agrupan para identificar necesidades, establecer metas colectivas, planificar y ejecutar acciones para su propio desarrollo y bienestar. No se trata solamente de la constitución formal de un grupo, sino de generar espacios de participación activa que promueven la corresponsabilidad, la cooperación y la toma colectiva de decisiones.

Al organizar a los miembros de una comunidad para alcanzar una meta común, se obtienen beneficios que van más allá del objetivo inicial, siempre que el proceso se realice de forma adecuada. Estos beneficios impactan positivamente en el poder colectivo, la autonomía y la equidad social.

La organización comunitaria amplía el potencial de cambio, ya que la voz colectiva de un grupo es mucho más poderosa que la de un individuo. Este esfuerzo conjunto permite a la comunidad ejercer una mayor influencia y lograr las transformaciones que desea ver. Es una estrategia eficaz para abordar problemas y generar soluciones sostenibles.

En salud pública, la organización comunitaria es estratégica para abordar los determinantes sociales y estructurales que afectan la salud. Proyectos exitosos parten de la premisa de que el poder reside en la comunidad y que la transformación es real cuando la población se apropia del proceso, lidera la identificación de problemas y se involucra desde la base en la búsqueda y ejecución de soluciones.

Las organizaciones que favorecen la vigilancia en salud pública, específicamente la vigilancia basada en comunidad puede darse mediante veedurías de salud, club de

usuarios del sistema general de seguridad social en salud, comités de vigilancias, redes de vigilancia en salud comunitaria, entre otras; quienes asumen funciones de gestión, incidencia, control social y garantía de derechos en el contexto. Además, cuando la organización se fortalece favorece la autonomía, la sostenibilidad y capacidad de respuesta de los desafíos propios de la comunidad e incluso externos (Richer, 2005).

Otra característica, que promueve la movilización social y autogestión es el empoderamiento, proceso mediante el cual individuos y comunidades incrementan su capacidad para controlar y tomar decisiones sobre los factores que influyen en su propia vida y salud. Implica adquirir conocimientos, habilidades y confianza para participar en el diseño, implementación y evaluación de las acciones que los afectan.

El empoderamiento no surge únicamente por ofrecer información, sino por crear las condiciones y brindar el acompañamiento para que las personas se reconozcan como sujetos activos, capaces de influir en su entorno y en las políticas públicas. En salud, esto implica pasar de un rol de pacientes pasivos a protagonistas que gestionan su propio bienestar — desde el autocuidado hasta la exigibilidad de sus derechos en los servicios de salud.

Este proceso en lo comunitario genera beneficios individuales y colectivos, mejora la autoestima y la percepción de capacidad, refuerza los lazos sociales y contribuye a una participación más equitativa y corresponsable. Además, es un motor fundamental para la sostenibilidad de los procesos de autogestión y movilización social, ya que fomenta la resiliencia, la innovación social y la defensa del interés común; incrementa la independencia de la comunidad, permitiéndole mantener un mayor control sobre su propio destino y reduciendo, a largo plazo, la necesidad de ayuda externa.

Por último, la organización comunitaria fomenta un mayor apoyo social y una mayor igualdad. Al unir a diversas personas para trabajar por un bien común, se crean nuevas conexiones y se fortalece el tejido social, lo que genera un crecimiento tanto personal como profesional. Este cambio en la distribución del poder, que se extiende de manera más amplia y equitativa, contribuye a una sociedad más justa al mejorar la situación de aquellos que tradicionalmente han sido marginados o ignorados.

1.4 Herramientas de análisis

Las herramientas de análisis en la participación social son instrumentos, metodologías y técnicas que facilitan la medición, seguimiento y fortalecimiento de los procesos participativos en salud pública y desarrollo comunitario. Su propósito es evaluar cómo, cuánto y con qué impacto distintos actores sociales se involucran y contribuyen a la toma de decisiones, la gestión de recursos y el control social sobre los temas que los afectan. (Sanabria, 2004).

Estas herramientas para medir la participación social permiten identificar actores clave, monitorear niveles de involucramiento, recoger percepciones, evaluar impactos y mejorar estrategias para alcanzar los objetivos colectivos. Ayudan a gestionar espacios de encuentro, comunicación, consulta y deliberación, tanto en escenarios presenciales como virtuales (Pazo Fernández, 2017).

Árbol de soluciones

Es una herramienta visual y analítica, que permite comprender las causas y efectos de los problemas comunitarios, especialmente los relacionados con la salud, siendo un ejercicio reflexivo que moviliza a la comunidad hacia el cambio positivo. Esta, permite identificar no solo el problema principal, sino también:

- **Raíces**

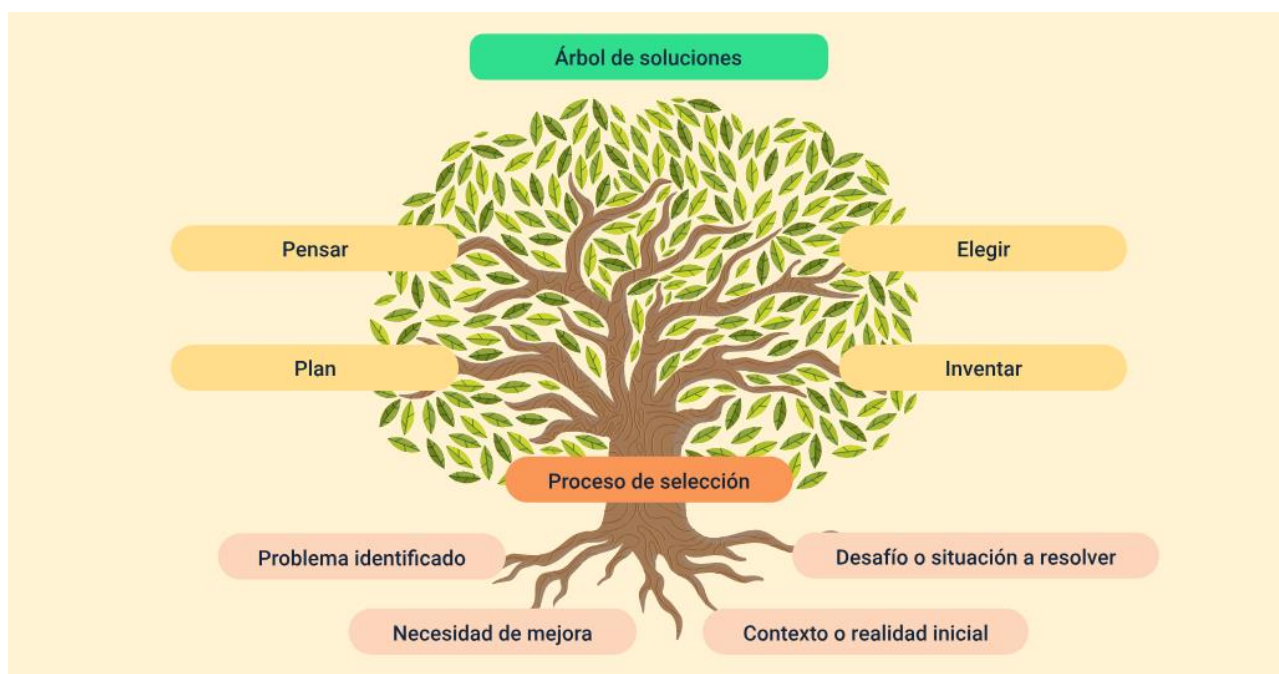
Causas del problema.

- **Ramas**

Posibles soluciones que pueden surgir desde la comunidad.

A continuación, se relaciona una figura al respecto:

Figura 1. Esquema árbol de soluciones



Árbol de soluciones

Pensar.

Plan.

Elegir.

Inventar.

¿Cómo funciona la metodología del árbol de soluciones?

Inicia con la identificación de un problema central, seguido por el análisis de sus causas y la definición de sus consecuencias. Esta metodología ofrece varios beneficios: brinda una visión integral, ayuda a priorizar acciones y fomenta la participación comunitaria en la búsqueda de soluciones reales. Además, busca generar la autogestión en los afectados y agentes comunitarios, así como promover la organización y movilización social, conectando a los ciudadanos con instituciones de salud y otros sectores, para facilitar la promoción de la salud, la prevención y control de eventos de interés en salud pública.

Para entender un poco esta herramienta, a continuación, se relaciona un ejemplo que se presentaría frente a una problemática de fiebre amarilla:

Figura 2. Árbol de soluciones para la enfermedad de fiebre amarilla



Árbol de soluciones para la enfermedad de fiebre amarilla

Campañas masivas.

Acceso a la vacuna.

Fumigación.

Eliminación de criaderos.

Vacunación

Campañas masivas.

Control del vector.

Uso de mosquiteros.

Educación

Campañas de concienciación.

Materiales informativos.

Vigilancia

Monitoreo de casos.

Reportes rápidos.

Diagrama de espina de pescado

Este diagrama también es conocido como Ishikawa o de Causa-Efecto, tiene por objeto organizar las causas de un problema específico. La estructura es semejante a un

esqueleto de un pescado en donde la cabeza es el problema y la espina representa las múltiples causas específicas de este.

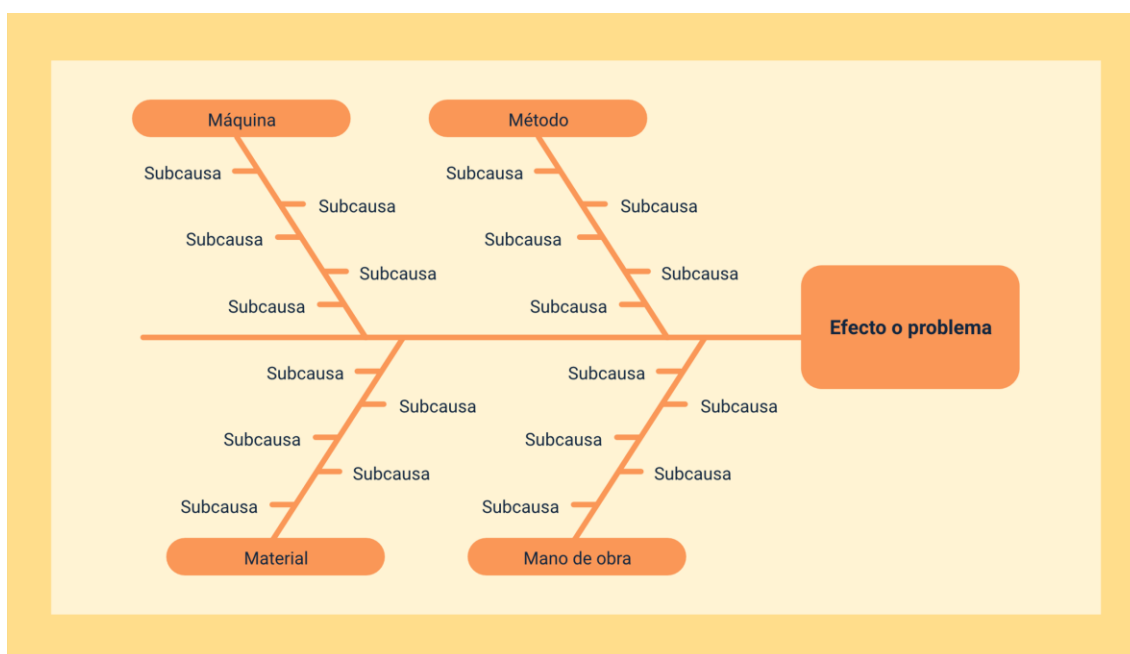
¿Cómo funciona la metodología del diagrama de espina de pescado?

El método para su desarrollo es por medio de una lluvia de ideas que se organizan según la categoría a la que corresponden, hasta encontrar la causa raíz, con base en lo que se presente se analiza y se busca la posible solución al problema.

Las oportunidades que brinda este método es la visualización clara de las posibles causas de un problema, facilitando la comprensión de este proceso, a su vez, al identificar las causas de raíz se profundiza en las causas del problema. Es una herramienta que favorece el trabajo de equipo, promoviendo la participación comunitaria y a su vez, permite la toma de decisiones de forma informada.

Partiendo de lo anterior, se relaciona la estructura de este diagrama:

Figura 3. Esquema de la espina de pescado



Esquema de la espina de pescado

Máquina

Subcausa.

Método

Subcausa.

Material

Subcausa.

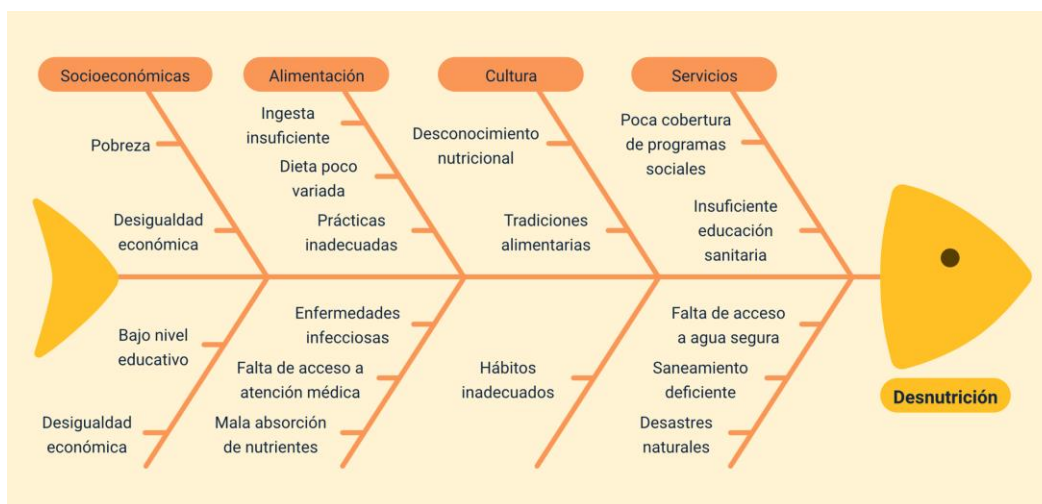
Mano de obra

Subcausa.

Efecto o problema

Ya conociendo la estructura de este diagrama, es importante analizar un ejemplo que trata el tema de la desnutrición y el cual se trata con esta herramienta:

Figura 4. Ejemplo diagrama espina de pescado. Herramienta de análisis



Ejemplo diagrama espina de pescado. Herramienta de análisis

Desnutrición

Servicios

- Poca cobertura de programas sociales.
- Insuficiente educación sanitaria.
- Falta de acceso a agua segura.
- Saneamiento deficiente.
- Desastres naturales.

Cultura

- Desconocimiento nutricional.
- Hábitos inadecuados.
- Tradiciones alimentarias.
- Hábitos inadecuados.

Alimentación

- Ingesta insuficiente.
- Dieta poco variada.
- Prácticas inadecuadas.
- Enfermedades infecciosas.
- Falta de acceso a atención médica.
- Mala absorción de nutrientes.

Socioeconómicas

- Pobreza.
- Bajo nivel educativo.
- Desigualdad económica.
- Desigualdad económica.

Basado en los procesos de análisis, previamente explicadas, el siguiente video presenta la movilización social como una estrategia fundamental en salud pública, que promueve la participación activa de la comunidad en la identificación, análisis y solución de los problemas sanitarios que la afectan directamente. Para comprender las causas y efectos de estos problemas, se emplean herramientas como son el árbol de soluciones y el diagrama de espina de pescado:

Video 2. Herramientas de análisis participativo para la implementación de acciones de mejora en el territorio



[Enlace de reproducción del video](#)

Video 2. Síntesis del video: Herramientas de análisis participativo para la implementación de acciones de mejora en el territorio

La movilización social es una estrategia clave en salud pública que involucra a la comunidad en la identificación, análisis y resolución de los problemas sanitarios que la afectan directamente.

A través de procesos participativos, esta herramienta fomenta el empoderamiento de las personas, permitiéndoles convertirse en agentes de cambio dentro de sus comunidades.

La consolidación de la movilización social se genera cuando el proceso cuenta con la participación, corresponsabilidad y construcción colectiva de la comunidad.

Para cumplir con esto deben existir varios elementos, entre ellos están:

- Diagnóstico participativo de necesidades.
- Convocatoria amplia y equitativa de actores sociales.
- Comunicación estratégica culturalmente adecuada.
- Fortalecimiento de capacidades y liderazgo comunitario.
- Evaluación y retroalimentación permanente para asegurar sostenibilidad.

La autogestión, ha sido definida como un proceso de organización y toma de decisiones autónoma protagonizado por individuos o comunidades, sin mediación de grupos externos.

La autogestión es una práctica social donde la comunidad define sus problemas, recursos y soluciones e implementa acciones conjuntas desde la equidad,

el empoderamiento y la participación directa en su transformación y autodefinición como sujetos activos.

La organización comunitaria es un proceso dinámico mediante el cual personas que comparten un territorio, una problemática o un interés común, se agrupan para identificar necesidades, establecer metas colectivas, planificar y ejecutar acciones para su propio desarrollo y bienestar.

El árbol de soluciones es una herramienta visual y analítica, que permite comprender las causas y efectos de los problemas comunitarios, especialmente los relacionados con la salud siendo un ejercicio reflexivo que moviliza a la comunidad hacia el cambio positivo.

La metodología del árbol de soluciones inicia con la identificación de un problema central, seguido por el análisis de sus causas y la definición de sus consecuencias.

El diagrama de espina de pescado tiene por objeto organizar las causas de un problema específico. Donde la cabeza del pescado es el problema y la espina representa las múltiples causas específicas de este.

El método se desarrolla por medio de una lluvia de ideas que se organizan según la categoría a la que corresponden hasta encontrar la causa raíz, con base en lo que se presente se analiza y se busca la posible solución al problema.

Metodología SARAR

Esta metodología tiene un enfoque educativo y de capacitación que favorece el desarrollo de la autoestima, el fortalecimiento asociativo, el ingenio, la planificación de acciones y la responsabilidad de las personas para la resolución de problemas dentro de la comunidad; el enfoque participativo se centra en la persona que aprende para fortalecer la capacidad para la toma de decisiones en salud y saneamiento bajo premisas de respeto y confianza. Este método tiene como énfasis la salud y saneamiento en las comunidades especialmente las rurales (Marinof, Amalia & Centurión, 2001).

Esta metodología corresponde a un acrónimo en inglés que corresponde a las siguientes cualidades:

- S** - **Self - esteem**
(Autoestima).
- A** - **Associative strengths**
(Fuerzas asociativas).
- R** - **Resourcefulness**
(Ingenio).
- A** - **Action plannig**
(Planificación de la acción).
- R** - **Responsability**
(Responsabilidad).

Para el desarrollo de este método se surten los siguientes pasos:

1. El diagnóstico participativo local.
2. Identificación de problemas y generación de análisis grupal.
3. Planificación colectiva de soluciones y acciones.
4. Implementación y seguimiento de los compromisos asumidos.

Empleando los instrumentos visuales que se desarrollan en actividades grupales mediante el diálogo de las situaciones que se presentan; con los resultados obtenidos se hace una evaluación de lo que ésta sucediendo, para una reflexión de lo que se presenta, los recursos con los que se cuenta y los que se deben gestionar para cada situación de interés en salud pública, que es adoptado en diferentes contextos culturales y sociales. Es necesario contar con un rol de facilitador para que acompañe, motive y garantice la horizontalidad de las relaciones y no se presente la forma tradicional de compartir los contenidos a desarrollar.

¿Cómo funciona la metodología del SARAR?

Para su realización esta metodología emplea herramientas didácticas y lúdicas (sociodramas, maquetas, títeres, historias, dinámicas, juegos, entre otras), concediendo a los participantes analizar su propia realidad e identificar las barreras o problemáticas existentes para su posterior diseño de estrategias de mejora en temas relacionados con factores que afectan la salud de las personas. Permitiendo, una reflexión crítica de lo que sucede en la comunidad, motivando la decisión colectiva para generar cambios en la comunidad.

Se recomienda que la sesión que se desarrolle sea por grupos homogéneos por edad y género, para fomentar la confianza y la participación, motivando un aprendizaje dinámico, adaptativo y contextualizado. Para el cierre de la sesión se propone exista una

evaluación y realimentación a los participantes como para facilitadores, asegurando la apropiación del proceso.

A continuación, se da un ejemplo sobre esta metodología, el cual trata sobre el manejo de los residuos sólidos en la comunidad San Miguel:

La comunidad San Miguel se localiza en el área rural, donde el servicio público de recolección de basuras solo cubre el área urbana no llegando a las veredas. Los habitantes han recurrido durante mucho tiempo a la quema y entierro de desechos o los arrojan a las áreas abiertas del campo. Estas acciones vienen generando un problema ambiental y de salud: debido a malos olores, proliferación de vectores, contaminación de agua y afectación a la biodiversidad local.

El impacto ambiental y social generado por la acumulación de residuos sólidos en botaderos improvisados ha deteriorado la zona, afectando su valor agrícola y contaminando las fuentes hídricas. Los desechos llegan a quebradas y ríos, poniendo en riesgo los cultivos, el agua para consumo de los habitantes y la comercialización de los excedentes agrícolas producidos por la comunidad. Además, las quemas al aire libre han incrementado los problemas de salud en niños y adultos debido a los gases liberados durante la incineración de los desechos, lo que ha aumentado los casos de enfermedades respiratorias y la presencia de plagas.

Algunos de los residentes de la comunidad San Miguel han iniciado el proceso de reciclaje de las basuras en desechos orgánicos y no orgánicos; sin embargo, se carece de educación ambiental y la baja cobertura del proceso de recolección no alcanza a cubrir la demanda que existe para el manejo de los residuos sólidos de la comunidad. A pesar, de que las autoridades locales han venido sensibilizando, planteando nuevas rutas de

recolección no ha sido suficiente para que exista un cambio de la actitud y comportamiento de la comunidad no siendo una respuesta eficaz para el territorio.

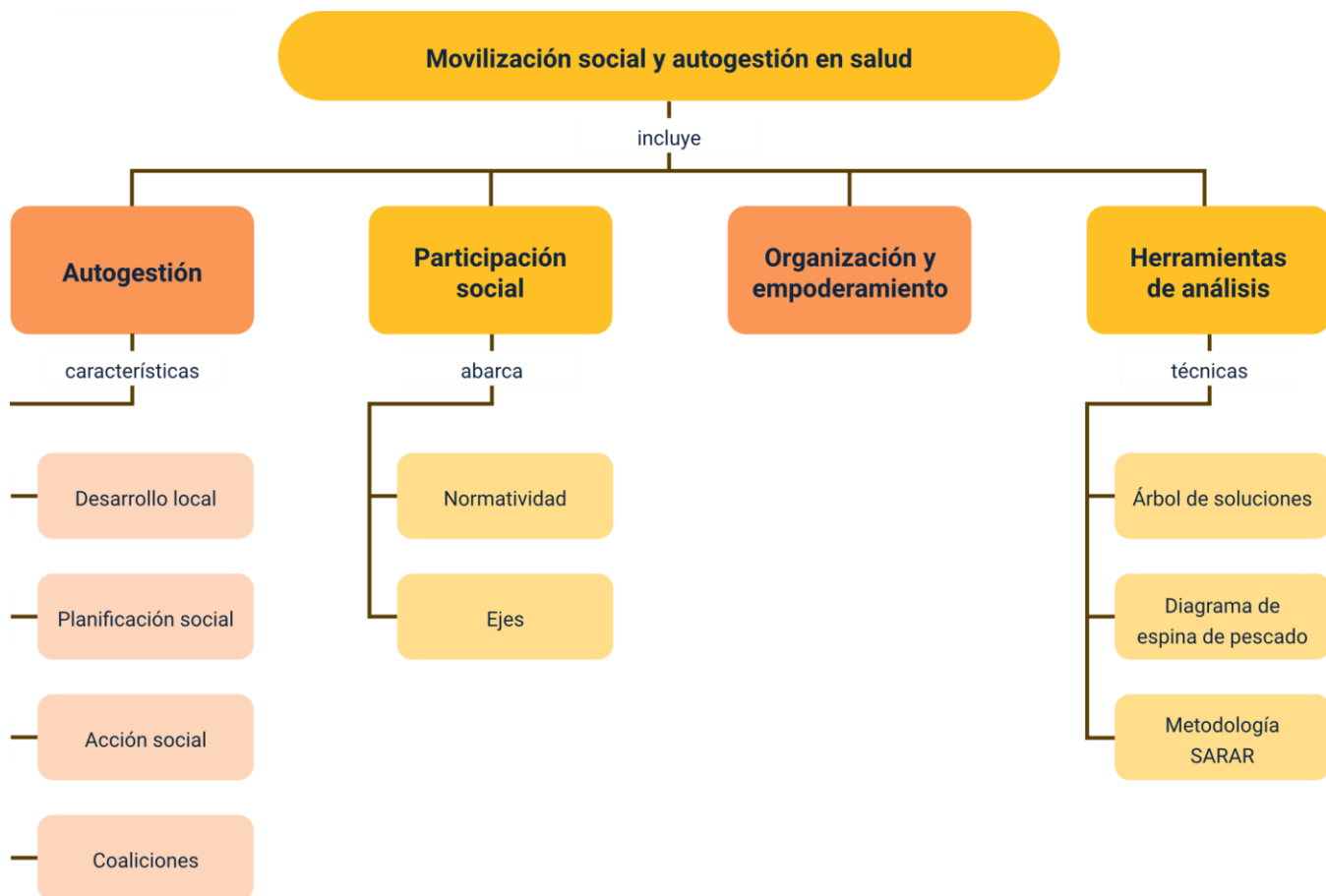
Con el paso del tiempo la comunidad reconoce que el impacto del manejo inadecuado de los residuos sólidos impacta de forma negativa a los residentes de este lugar; por ello, inicia debates públicos en busca de alternativas de solución en los que se involucren organizaciones locales para diseñar un sistema comunitario, para el manejo de residuos sólidos de forma integral. Para esto, se plantean proyectos de educación ambiental y autogestión con el objeto de mejorar la calidad de vida y reducir los factores que desencadenan efectos adversos en la salud colectiva.

Síntesis

Este componente formativo ofrece una visión integrada de los procesos que fortalecen la acción colectiva en las comunidades, abordando la movilización social como un mecanismo para promover la organización, la autogestión y la toma de decisiones informadas en torno a la salud y el bienestar común. Se destacan los fundamentos conceptuales de la participación social, su marco normativo y las diversas formas mediante las cuales la ciudadanía interviene activamente en la identificación de necesidades, la formulación de propuestas y la construcción de soluciones.

Asimismo, se resalta el papel del empoderamiento y la organización comunitaria como elementos que permiten consolidar capacidades locales, generar liderazgo y fomentar la corresponsabilidad en la gestión de iniciativas que mejoren las condiciones de vida. Para ello, se introducen herramientas participativas de análisis — como el árbol de soluciones, el diagrama de espina de pescado y la metodología SARAR — que facilitan la comprensión de problemas, la búsqueda colaborativa de alternativas y la planificación de acciones estratégicas.

En conjunto, esta temática promueve una comprensión amplia de los procesos participativos y de autogestión aplicados al contexto comunitario, reafirmando su importancia para impulsar transformaciones sostenibles, fortalecer la cohesión social y consolidar una participación activa y propositiva en los asuntos que afectan el bienestar colectivo.



Material complementario

Tema	Referencia	Tipo de material	Enlace del recurso
1. Movilización social.	Instituto Nacional de Salud. (2025). Caja de herramientas para la gestión del riesgo colectivo en brotes, epidemias y eventos de interés en salud pública. Etapa 1.2. Sistema de alerta temprana: Vigilancia Basada en Comunidad-fases de implementación.	Manual.	https://www.ins.gov.co/Noticias/revcom/Etapa%201.2.%20Sistema%20de%20alerta%20temprana%20vigilancia%20basada%20en%20comunidad,%20fases%20de%20implementaci%C3%B3n%20caja.pdf
1. Movilización social.	Instituto Nacional de Salud. (2025). Lineamientos para la Vigilancia Basada en la Comunidad.	Documento.	https://www.ins.gov.co/Noticias/revcom/Lineamientos%20para%20la%20Vigilancia%20Basada%20en%20Comunidad%202025.pdf

Tema	Referencia	Tipo de material	Enlace del recurso
1.1. Autogestión	Rodríguez Tamayo, N. A. (2019). La autogestión como resistencia, dos ejemplos en América Latina. Kavilando, 11.	Artículo.	https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7225263
1.4. Herramientas de análisis.	Pazo Fernández, C. A. (2020). Salud y participación social en Colombia. Análisis y reflexiones de las condiciones actuales para el ejercicio de la democracia.	Artículo.	https://revistas.upb.edu.co/index.php/trabajo-social/article/view/6693

Glosario

Autogestión: capacidad de las personas y comunidades para gestionar y decidir sobre sus propios procesos.

Control social: mecanismos ciudadanos para vigilar y exigir transparencia en la gestión pública.

Corresponsabilidad: compromiso compartido de todos los actores en la transformación social o sanitaria.

Diagnóstico participativo: identificación colectiva y reflexiva de necesidades y problemas comunitarios.

Empoderamiento: desarrollo de capacidades y liderazgo comunitario para incidir en decisiones y recursos.

Liderazgo social: habilidad de guiar y movilizar a la comunidad en procesos colectivos.

Movilización social: proceso colectivo en el que la comunidad actúa para transformar su realidad y salud.

Organización comunitaria: agrupamiento estructurado de personas para identificar y resolver necesidades comunes.

Participación social: involucramiento activo de la ciudadanía en la gestión y control de los asuntos de salud.

Sostenibilidad: capacidad de mantener en el tiempo logros y transformaciones alcanzadas por la comunidad.

Referencias bibliográficas

Bauni, N. (2022). Innovar y autogestionar: Teorías y experiencias históricas sobre innovaciones organizacionales en la autogestión. TeseoPress.

Centro de estudios en democracia y asuntos electorales. (2014). Una mirada desde los movimientos campesinos y el paro nacional agrario.

[https://www.registraduria.gov.co/IMG/pdf/Caracterizacion de las organizaciones sociales.pdf](https://www.registraduria.gov.co/IMG/pdf/Caracterizacion_de_las_organizaciones_sociales.pdf)

Centro para la Salud y Desarrollo Comunitario de la Universidad de Kansas. (2025). Caja de herramientas comunitarias: Organizar la movilización comunitaria.

<https://ctb.ku.edu/es/mejores-procesos-de-cambio/organizar-la-movilizacion-comunitaria/vision-general>

Congreso de Colombia. (2011, 19 de enero). Ley 1438 de 2011. Por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones.

<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=41355>

Congreso de Colombia, (2015, 16 de febrero). Ley Estatutaria 1751 de 2015. Por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones.

<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=60733>

Constitución Política de la República de Colombia. (1991). Autor.

Contreras Hernández, J. G. (2022). ¿Qué es un movimiento social? y su importancia en el estudio de la ciencia política. *Revista de La Facultad de Derecho y Ciencias Políticas*, 52(136), 68-100.

<https://doi.org/10.18566/rfdcp.v52n136.a04>

Eugenio, J. L., Mejía Mendoza, M. L., Figueroa, I. V. & Márquez A, J. M. (2014). *Movilización social y determinantes sociales de la salud: proceso educativo en comunidad rural de Jalisco. Estudio Sociales.*

García Jerez, F. A. (2016). La movilidad socio-espacial desde la teoría de Pierre Bourdieu: capital de motilidad, campo de movilidad y habitus ambulante 1. *Sociedad y Economía*, 31, 15-32.

<http://www.scielo.org.co/pdf/soec/n31/n31a02.pdf>

Hudson, J. P. (2010). Formulaciones teórico-conceptuales de la autogestión. *Revista Mexicana de Sociología*, 72(4), 571-597.

<https://www.scielo.org.mx/pdf/rms/v72n4/v72n4a3.pdf>

Instituto de Estudios Latinoamericanos. (2025). *Participación Social.*

Marinof, N., Amalia Pesantes, M. & Centurión, C. (2001). *Metodologías participativas en educación sanitaria Una adaptación de SARAR PHAST para comunidades rurales andinas.*

[https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/INEC/IETS/guia-del-orientador-metodologias-participativas-en-educacion-sanitaria-\(saras-1\).pdf](https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/INEC/IETS/guia-del-orientador-metodologias-participativas-en-educacion-sanitaria-(saras-1).pdf)

Ministerio de Salud y Protección Social. (2016, 17 de febrero). Resolución 0429 de 2016. Por medio de la cual se adopta la Política de Atención Integral en Salud.

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%200429%20de%202016.pdf

Ministerio de Salud y Protección Social. (2017, 9 de junio). Resolución 2063 de 2017. Por la cual se adopta la Política de Participación Social en Salud - PPSS.

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%202063%20de%202017.pdf

Ministerio de Salud y Protección Social. (2017). Política de Participación Social en Salud PPSS. Resolución 2063 de 2017.

<https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/GT/politica-ppss-resolucion-2063-de-2017-cartilla.pdf>

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. (1976). Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Organización Mundial de la Salud (OMS). (2022). Voz, agencia, empoderamiento - Manual sobre la participación social para la cobertura sanitaria universal.

Paris Pombo, M, D. (2012). La fabricación de armas para una revolución simbólica. Pierre Bourdieu y la sociología de la dominación. Sociológica, 77, 7-34.

<https://www.scielo.org.mx/pdf/soc/v27n77/v27n77a1.pdf>

Pazo Fernández, C. A. (2020). Salud y participación social en Colombia. Análisis y reflexiones de las condiciones actuales para el ejercicio de la democracia.

<https://revistas.upb.edu.co/index.php/trabajosocial/article/view/6693>

Richer, M. (2005). Participación y organización comunitaria en el sector salud: Servicios sociales quebequense. *Revista de Ciencias Sociales*, 11(2).

Rodríguez Tamayo, N. A. (2019). La autogestión como resistencia, dos ejemplos en América Latina. *Kavilando*, 11.

<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7225263>

Sanabria R, G. (2004). Participación social en el campo de la salud. *Revista Cubana de Salud Pública*, 30(3). Tilly, C. & Wood, L. J. (2010). *Los movimientos sociales*. Editorial Crítica. S.L., Ed.; Segunda, pp. 13-30.

Torres Tovar, M., Vega Romero, R. R., Luna García, J. E. & Otros autores. (2022). *Movilizaciones sociales por la Salud en Colombia* (Universidad Nacional de Colombia, Ed.).

Vera Martínez, J. & Ceballos Villada, Z. (2021). Autogestión comunitaria: una apuesta para la investigación y la intervención. *Acciones de Psicología Comunitaria desde los escenarios académicos, comunitarios e investigativos*.

<https://libros.unad.edu.co/index.php/selloeditorial/catalog/download/46/32/917?inline=1>

Créditos

Nombre	Cargo	Centro de Formación y Regional
Milady Tatiana Villamil Castellanos	Responsable Ecosistema de Recursos Educativos Digitales (RED)	Dirección General
Diana Rocio Possos Beltrán	Responsable de línea de producción	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima
Sandra Paola Cataño Mora	Contratista	Instituto Nacional de Salud
Luz Dary Quintero Torres	Contratista	Instituto Nacional de Salud
Gina M. Morales S	Contratista	Instituto Nacional de Salud
Fabian Nicolas Moreno Anzola	Contratista	Instituto Nacional de Salud
Diego Felipe López Ávila	Contratista	Instituto Nacional de Salud
Diana Alexandra Moreno Santamaria	Contratista	Instituto Nacional de Salud

Nombre	Cargo	Centro de Formación y Regional
María Elena Tamayo Bustamante	Asesora metodológica	Centro de Formación de Talento Humano en Salud - Regional Distrito Capital
Eliana Milena Buitrago Umaña	Asesora metodológica	Centro de Formación de Talento Humano en Salud - Regional Distrito Capital
Andrés Felipe Velandia Espitia	Evaluador instruccional	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima
Oscar Iván Uribe Ortiz	Diseñador web	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima
José Jaime Luis Tang Pinzón	Diseñador web	Centro de Comercio y Servicios – Regional Tolima
José Yobani Penagos Mora	Diseñador web	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima
Francisco José Vásquez Suárez	Desarrollador full stack	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima
Ernesto Navarro Jaimes	Animador y productor audiovisual	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima

Nombre	Cargo	Centro de Formación y Regional
Norma Constanza Morales Cruz	Evaluadora de contenidos inclusivos y accesibles	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima
Javier Mauricio Oviedo	Validador y vinculator de recursos educativos digitales	Centro de Comercio y Servicios - Regional Tolima